

为圆形粉色直径约 1cm 大的表面刻有“P”字的片剂,目前对其产地,含量成份尚不清楚,前二例患者均有解热镇痛药过敏史,后一例有食用鱼虾过敏史,三例服用“摇头丸 P”迅速出现皮肤症状,诊断“药疹及过敏性紫癜”无疑义。前二例患者服用各类摇头丸均半年以上未出现皮肤反应,而首次服用:“摇头丸 P”即出现皮疹,推测其除含有 MDMA, MAMP 外,其中可能含有类似解热镇痛药及其它杂质成份致敏所致。

3、前二例患者皮肤反应较重,第一例患者出现精神症状,分析与短时间内使用的剂量过大,为常规量(半片)的 6 倍有关。

4、摇头丸(MDMA)在社会上被认为是一

种娱乐性药物,使人体产生欣快感和增加活力的感觉,但人们对兴奋剂对人体的危害及精神依赖成瘾性认识不足,并产生误区,认为对人体危害不大,不易成瘾。(如本文前二例使用摇头丸半年以上在询问病史中本人均不认为成瘾)在我国青少年中甚至成人中滥用兴奋剂快速增长,目前虽然已引起我国政府的高度重视,并加强打击力度,作者认为兴奋剂滥用已成社会问题,卫生部门应抓紧时机积极配合各部门进行全民族的远离毒品,禁止滥用兴奋剂的教育,以增加自身防护意识提高全民族素质是十分重要的。

多药联用致重型多形红斑 一例药物相互作用分析

赵玉芬

(上海铁路局中心医院 邮编 200072)

一、一般资料

患者男,37 岁,嗜烟酒,幼年因胆道蛔虫行手术治疗,入院前曾因腰椎间盘突出就诊。

二、致敏药物

患者因腰部疼痛于 1998 年 11 月 3 日服用卡马西平片 0.1g tid,优妥胶囊 90mg/日,吠喃硫胺片 20mg 日服三次,扶他林乳剂局部外用。用药 9 天后咽痛,13 天发热于就近医院急诊予安乃近、青霉素 G 钠注射,泰诺控释片、阿莫西林胶囊口服(用法不详),用药当日发疹。

三、皮疹类型

患者头颈、躯干部泛发多形红斑型药疹。入院次日向下肢及生殖器蔓延,体温 42℃、咽部、口腔粘膜呈片状坏死脱落,周围粘膜充血肿胀,伴眼球结膜水肿。

四、治疗经过

立即停用上述各药,禁烟酒。静脉补液并静滴林可霉素 1.8g/日,甲硝唑 100ml 日服二

次预防感染,氢化可的松 200mg/日,维生素 C 2.0g/日,扑尔敏 10mg/日,分别静滴抗过敏,2 日后转院治疗。

五、讨论

(一)患者在两周内合并应用了出自不同医院处方的八种药物,包括四种非甾体抗炎药、两种内酰胺类抗生素、一种维生素及卡马西平。

根据北京协和医院发布的资料,用药七种则 ADR(药品不良反应)发生率为 38.46%。提示临床用药应特别注意患者的用药史,生理、病理及免疫状况,能用一种药就不用两种药,确保患者的用药安全。

(二)卡马西平与非甾体抗炎药发生相互作用,在嗜酒者中发生中枢胆碱毒性的可能性更大,影响下丘脑调温中枢致体温升高,近来报道的卡马西平重症药疹 9 例与本例均具此特点。随着卡马西平应用范围的拓展,由其引起的重症皮疹亦较常见,建议临床医师在用药时充分

评估风险/效益。

(三) 优妥胶囊为阿西美辛缓释剂, 在体内主要代谢为吡咪美辛而生效, 经肝脏代谢、肾脏排泄、部分从胆汁和粪中排泄, 联用青霉素可减少其排泄。当支配 ADR 发生的药物代谢物排出延缓且使用缓释剂型时(如优妥和泰诺), 重复给药有时可导致极险重的 ADR。需要强调的是服用本品时忌同时服用其它非甾体抗炎药, 多种非甾体抗炎药联合应用弊大于利, 这已为国外研究资料证实。机理可能是多种理化性质相同的药物可在相同的蛋白质结合位点上发生竞争。乙醇和烟草均为肝药酶诱导剂, 可能加速药物代谢为毒性代谢产物。在消除能力下降

时, 这些复杂的药物相互作用的结果可能具有重要的临床意义。

(四) 卡马西平、优妥等药物均存在肠肝循环。据国内外研究, 卡马西平血药浓度具有多峰现象, 口服卡马西平的血浓多峰现象产生机理主要为肠肝循环和胃肠道吸收的非齐性。卡马西平在人体内几乎完全被肝脏中细胞色素 P₄₅₀ 酶 3A₄ 所代谢, 代谢产物 72 小时经尿排泄, 28 小时随粪便排出, 故而发生肠肝循环。在胃肠道的不同部位, 管壁对药物通透性不同造成吸收的非齐性。因此使卡马西平在人体内吸收延长。卡马西平引起的药疹以重型多见, 可能与此机理有关。

胆道术后药物热 5 例分析

李明启 张建民

(山东枣庄市立医院 枣庄 邮编 277102)

自 1991 年 1 月以来, 我们收治胆道术后药物热 5 例, 报告如下。

一、临床资料

本组男 3 例, 女 2 例; 年龄 40~70 岁, 平均年龄 57.1 岁。胆总管结石 3 例, 胆总管末端癌、肝门部胆总管癌各 1 例。5 例均伴有梗阻性黄疸、胆汁淤积性肝硬化, GPT、GOT 均高于正常值 2 倍以上。手术方法: 胆囊切除+胆总管切开取石+T 管引流 3 例, 胰头十二指肠切除、肝门部肿瘤切除+左右肝管置管+肝门空肠 Roux-y 吻合各 1 例。术后均以青霉素、哌拉西林、甲硝唑为主的三联用药, 时间为 8~13 天, 平均 9.5 天, 有 3 例因高热改用头孢哌酮(先锋必素)。4 例病人术后一直低热($<38.5^{\circ}\text{C}$) 6~12 天出现高热; 另一例术后体温正常后于第 9 天突然高热。体温均波动在 $39.1\sim40.9^{\circ}\text{C}$ 之间, 呈弛张热, 表现在每日用药后 2~3 小时后开始高热, 每日发作及持续时间均规律, 经应用复方氨基比林效果差。5 例患者既往合并风湿性关节炎、高血压、慢支各 1 例, 病史为 3~10 年; 一

例在内科误诊为重症胰腺炎(ACST) 治疗 1 周转入我科; 另一例有胆结石症的三次发作史, 均有大剂量用药史。本组 5 例病人经停用全部药物后, 体温均在 24 小时降至正常且未再发作, 符合药物热的诊断标准^[1,3]。

二、讨论

(一) 误诊原因 近年来随着耐药菌群的增多, 胆道手术后常三联应用抗菌药且用药时间偏长, 致使临床上极少数病人出现了难以诊断的术后药物热。其误诊原因: 1. 既往少见, 文献中亦未见这方面的专题报告, 因此临床医师对该病缺乏认识; 2. 胆道术后胆系感染、胆瘘、膈下脓肿、吻合口瘘、败血症、二重感染等均可引起高热, 临床医师过于重视对后者的诊治。如本组 3 例病人的药物热未能及时得以诊断, 而考虑腹腔内隐匿性炎症而改用头孢哌酮钠(Cefoperazone sodium) 延误了治疗。

(二) 诊断 笔者结合药学文献, 认为以下几点有助于该种药物热的诊断: 1. 合并慢性病的中老年病人; 老年人易出现药物不良反